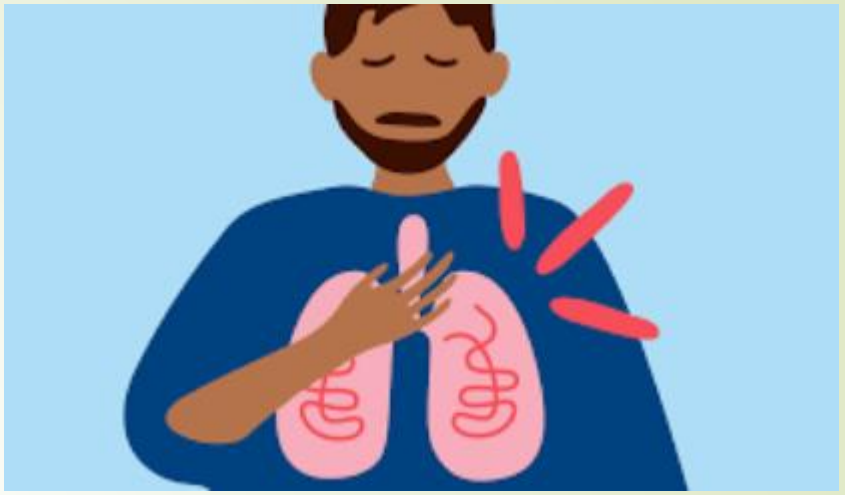
Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Semiologie respiratoire

Signes fonctionnels respiratoires : la dyspnée

Dr: K.CHIBANI

Définition



- Difficulté ou gêne à respirer
- À différencier de l'hyperventilation : augmentation de l'amplitude respiratoire sans gêne respiratoire (fausses dyspnées d'origine métabolique).
- La fréquence respiratoire : nombre de mouvements respiratoires par minute varie avec l'âge

au repos elle est de :

— 14 à 22 mouvements/minute chez l'adulte;

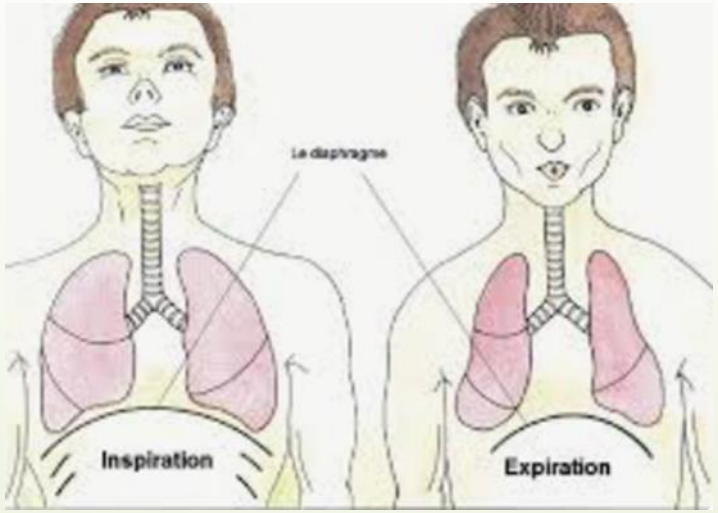
— 22 à 30 mouvements/minute chez l'enfant.

augmentation à l'effort et en altitude.

Rappel physiologique de la respiration

- La respiration normale est automatique, involontaire et inconsciente
- Deux temps:
  - L'inspiration: temps actif
  - L'expiration : temps passif

Le temps expiratoire est plus long que le temps inspiratoire.



Rappel physiologique de la respiration

- La respiration est un acte réflexe

— Des voies centripètes: fibres d'origine corticale, fibres d'origine pulmonaire et fibres d'origine sino-carotidienne,

— Un centre respiratoire : bulbaire situé dans le plancher du ventricule.

excité directement par la pression partielle de CO2 et le pH sanguin et indirectement par l'intermédiaire des fibres centripètes d'origine sino-carotidienne par l'hypoxie.

— Des fibres centrifuges: nerf phrenique

Mécanisme de la respiration

- le réflexe de Héring-Breuer: l'inspiration appelle l'expiration,

Inspiration → distension du poumon → excitation des fibres d'origine pulmonaire → envoie d'un influx inhibiteur au centre respiratoire → suspension de son activité → expiration → absence d' influx inhibiteur au cours de l'expiration → reprise d'activité son activité → excitation du nerf phrénique → inspiration.

Analyse sémiologique de la dyspnée :

- Signe subjectif
- Interrogatoire:
  - date de début,
  - mode de début : brutal ou progressif,
  - Circonstances d'apparition : le caractère spontané ou provoqué (effort, fumée, saison),
  - évolution dans le temps : permanente ou paroxystique,
  - horaire dans le nycthémère (diurne ou nocturne),
  - existence de signes accompagnateurs
- Inspection : fréquence respiratoire, amplitude et la durée des deux temps de la respiration

Les différents types de dyspnée :

- Selon le mode de début :

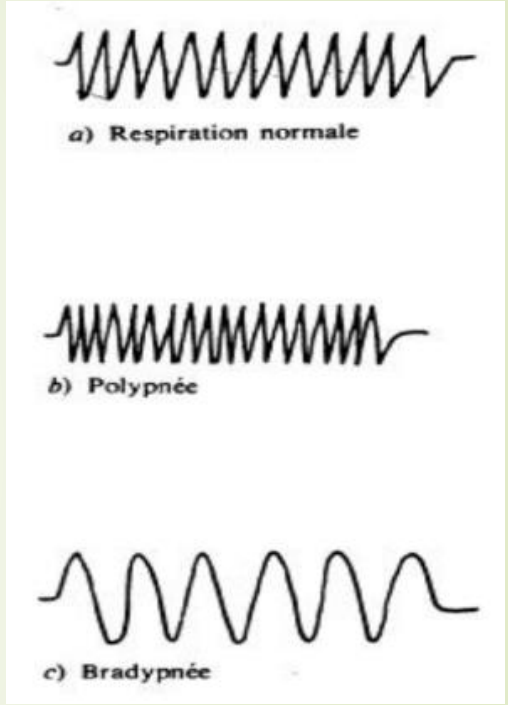
— Dyspnée aiguë : début brutal

— Dyspnée chronique : début progressif.

- Selon les circonstances d'apparition :

— la dyspnée d'effort : efforts très limités et courants, se prolonge au-delà de la durée normale (plus de 5 minutes) après la cessation de l'effort et augmente dans le temps pour des efforts de plus en plus restreints.

Les différents types de dyspnée :



- **Selon le mode d'évolution :**
  - Dyspnée paroxystique
  - Dyspnée permanente : ou dyspnée de repos,
    - Précédée par une dyspnée d'effort;
    - Parfois orthopnée.
- **Selon la fréquence respiratoire :**
  - Polypnée : Fr > 22 mouvements/minute chez l'adulte et à 30 mouvements/minute chez l'enfant
  - Bradypnée : Fr < 14 chez l'adulte et 22 chez l'enfant.

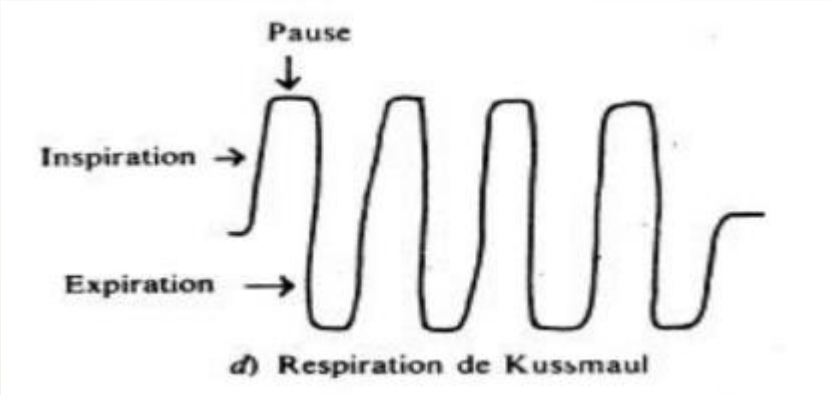
Les différents types de dyspnée :

- **Selon le temps respiratoire :**
  - Bradypnée inspiratoire :
    - obstacle à la pénétration de l'air : obstruction laryngée (laryngite, fausses membranes ou corps étranger).
    - dyspnée aiguë
    - Cornage et tirage
  - Bradypnée expiratoire :
    - obstacle à la sortie de l'air : atteinte diffuse des bronches (crise d'asthme)
    - dyspnée paroxystique,
    - sifflements expiratoires : respiration sifflante: sibilants
  - Dyspnée mixte : inspiratoire et expiratoire,
    - pathologie trachéale , métabolique ou toute pathologie pulmonaire sévère ,
    - parfois difficile pour le patient de déterminer le temps ,

Les fausses dyspnées (dyspnées sine materia)

Sans substratum anatomique (pas de gêne respiratoire).

- La respiration de Kussmaul :
  - hyperventilation réalisant une respiration lente, régulière et profonde, égale aux deux temps qui sont séparés par une pause (respiration en créneau).
  - états d'acidose métabolique diabétique ou rénale



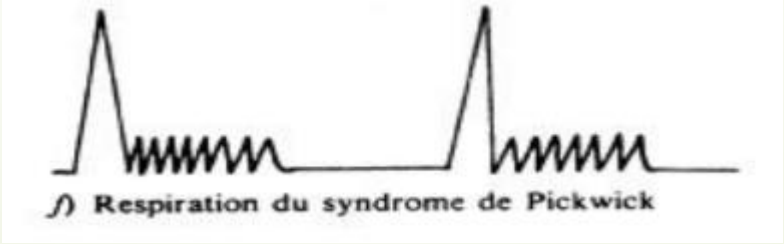
Les fausses dyspnées (dyspnées sine materia)

- La respiration périodique de Cheyne-Stokes : témoin d'un désordre nerveux central.
  - irrégularité du rythme respiratoire : cycles respiratoires d'amplitude croissante devenant bruyants, puis d'amplitude décroissante aboutissant à une pause complète de quelques secondes ou apnée.
  - Cette périodicité apparaît du fait de l'alternance de phases d'hypercapnie et d'hypo-capnie qui provoquent successivement une hyperventilation puis une hypoventilation



Les fausses dyspnées (dyspnées sine materia)

- La respiration périodique du syndrome de Pickwick :
  - irrégularité du rythme respiratoire,
  - se voit chez certains obèses, elle est alors associée à une somnolence diurne.
  - respiration périodique nocturne,
  - succession de cycles caractérisés par une inspiration lente et profonde, suivie de mouvements respiratoires courts et rapides et d'une apnée expiratoire complète



Evaluer le sévérité de la dyspnée

- Classification selon les stades de NYHA(New york Heart Association):

Stade I: aucune limitation d'activité physique

Stade II : dyspnée pour des efforts intenses de la vie quotidienne (montée des escaliers)

Stade III: dyspnée pour les efforts légers avec limitation importante (toilette, se coiffer)

Stade IV: dyspnée de repos (s'assurer que ces limitations sont d'origine respiratoires et non pas d'ordre articulaire ou coronarienne)

- Au mesures indirecte de la dyspnée: **Sadoul 1983, Echelle du Medical Research Council**

MERCI

Reference

- Précis de sémiologie
- Dyspnée aigue ou chronique. Collège des enseignants de pneumologie 2023